DATO DE ATENCIÓN URGENCIA (DAU)

ESTABLECIMIENTO	:	HOSPITAL SAN CARLOS	N°DAU	:	4254309
CALIDAD	:	Original	FECHA	:	18/09/2025 16:06
AREA	:	U.E. Adulto	BOX	:	Camilla
HC	:	2000150499	CTA. CTE.	:	0

DATOS CONSULTANTE:

Nombre : LUZ MARILI CARO QUIROZ **RUN** : 9.632.454-5 **CP** : 274822
Previsión : FONASA A **F.Nac** : 05/08/1964 **Género** : Femenino **Edad** : 61 Años 1 Mes 13 Días
Dirección : BUIN 134 NAN ACT// **Comuna** : SAN CARLOS **Teléfono** : 968304588

DATOS INGRESO:

Procedencia : 1_EXTERIOR **Mot. Consulta** : MORBILIDAD COMUN
Lug. Ocurrencia : NO_ESPECIFICADO **Med. Llegada** : SAMU 1

SELECTOR DEMANDA: 1° llamado: 18/09/2025 16:09:17;

Profesional : Camila Llanos Morales **Hra. Llamada** : 18/09/2025 16:09 **Hora Atención** : 18/09/2025 16:14
T° Axilar : 0 **T° Rectal** : **Presión** : **Pulso** : 117 **Frec. Resp.** : 0
Saturometría : 96 **HGT** : **Peso** : **Glasgow** : **Clasificación** : C3
Motivo de consulta: : TRAIDA POR M1 POR EMESIS TIPO FECALOIDEO / GLW 14 BASAL
AM. CA OSEO EN CP / DEPENDENCIA SEVERA
ALERGIAS. PREDNISONA Y PIROXICAM
SAT 96
FC 117
PA 123/66

QUEDA EN CAMILLA

CONTROL SIGNOS VITALES:

Fecha	Pulso	Presión	T° Axilar	T° Rectal	FR	Sat.	HGT	Profesional
18/09/2025 16:52	75	93/67	36.7			95		YUERLY RIQUELME VALENZUELA
18/09/2025 18:58	89	78/50	36.4			93	124	YUERLY RIQUELME VALENZUELA
18/09/2025 20:20	72	105/61				94		ANA OSSES FLORES

ACCIDENTE, ALCOHOLEMIA Y/O TOXICOLOGIA:

INFORME LESIONES : NO **INFORME ALCOHOLEMIA:** : NO

ANAMNESIS: 1° llamado a box: 18/09/2025 16:21:37;

Fecha	Anamnesis	Profesional
18/09/2025 16:51	AM: MIELOMA MULTIPLE EN CP AQ: COLECISTECTOMIA ALERGIAS: PIROXICAN, PREDNISONA TRAIDA POR HIJA QUIEN REFIERE 7 DIAS DE COMPROMISO DEL ESTADO GENERAL, INAPETENCIA Y SOMNOLIENCIA PROGRESIVA.	NICOLÁS BRAVO ALVEZ

EXAMEN FÍSICO :

Fecha	Examen Físico	Profesional
18/09/2025 16:51	REGULAR ESTADO GENERAL SOPOR SUPERFICIAL GLASGLOW 9P MP(+) SRA SIN APREMIO SIN UMA ABDOMEN DISTENDIDO DOLOR A PALPACIÓN EN HD EEII: POSTURA VICIOSA, DOLOR A PALPACIÓN DE FEMUR IZQUIERDO, SIN SIGNOS DE TVP, SIN EDEMA, TIBIA A DISTAL	NICOLÁS BRAVO ALVEZ

DIAGNÓSTICOS: **Condición de ingreso:** Conciente

Fecha	Hipótesis diagnóstica	Profesional
18/09/2025 22:11	N39.0 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	NICOLÁS BRAVO ALVEZ

PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y/O TERAPÉUTICOS (TRATAMIENTO EN BOX):

Fecha	Procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos	Profesional	Estado	Responsable
18/09/2025 16:52	500CC SS 0.9% + 1G METAMIZOL + 1 AMP VIADIL	NICOLÁS BRAVO ALVEZ	Ejecutado el 18/09/2025 17:12	Felipe Lagos Fernandez
18/09/2025 16:52	EXAMENES SANGUINEOS	NICOLÁS BRAVO ALVEZ	Ejecutado el 18/09/2025 17:11	Felipe Lagos Fernandez
18/09/2025 19:27	500cc ss 0.9% bolo	NICOLÁS BRAVO ALVEZ	Ejecutado el 18/09/2025 19:35	Francisco Parada Riquelme
18/09/2025 19:27	ceftriaxona 2g ev	NICOLÁS BRAVO ALVEZ	Ejecutado el 18/09/2025 19:35	Francisco Parada Riquelme
18/09/2025 19:56	SV	NICOLÁS BRAVO ALVEZ	Ejecutado el 18/09/2025 20:20	ANA OSSES FLORES
18/09/2025 20:53	SUERO GLUCOSALINO A 60ML/H	NICOLÁS BRAVO ALVEZ	Ejecutado el 18/09/2025 21:22	Valentina de Jesús Medel Bravo
18/09/2025 20:53	SONDA NASOGASTRICA	NICOLÁS BRAVO ALVEZ	Ejecutado el 18/09/2025 21:21	Valentina de Jesús Medel Bravo Obs:ie tomas campos troncoso
18/09/2025 22:22	GLUCONATO DE CALCIO 2 AMP EV	NICOLÁS BRAVO ALVEZ	Ejecutado el 18/09/2025 22:29	NICOLÁS BRAVO ALVEZ

EXAMENES:

Fecha	Examen	Profesional
18/09/2025 16:53	RCTO GLOBULAR ; GLICEMIA ; UREMIA ; CREATININEMIA ; PERFIL LIPIDICO ; ALBUMINA ; E.L.P. ; PCR ; ORINA COMPLETA ; PROTROMBINA ; TTPK ; INR ; CALCIO ; FOSFORO ; GASES VENOSO ;	NICOLÁS BRAVO ALVEZ
18/09/2025 16:53	PERFIL HEPATICO ;	NICOLÁS BRAVO ALVEZ
18/09/2025 16:52	RX ABDOMEN SIMPLE,TC. ABDOMEN Y PELVIS CON CONTRASTE	Nicolás Bravo Alvez

INDICACIONES ALTA:

Fecha	Indicación	Profesional
18/09/2025 22:05	HOSPITALIZAR EN HDOM	NICOLÁS BRAVO ALVEZ
18/09/2025 22:13	HOSPITALIZAR EN HODOM RÉGIMEN PAPILLA POR SNG RL 500CC CADA 24H EV PARACETAMOL 500MG 2 COMP CADA 8H X SNG DICLOFENACO 300MG 2 COMP CADA 8H X SNG EN CASO DE DOLOR PARCHE DE BUPRENORFINA 1 PARCHE CADA 12H TRANSDERMICO CEFTRIAXONA 2G CADA 24H EV (1/7) OMEPRAZOL 20MG CADA 24H X SNG POR 7 DIAS ONDANSETRON 4MG CADA 8H X SNG EN CASO DE NAUSEAS O VOMITOS SEGUIMIENTO POR FONOAUDIOLOGA CONTROL DE PI EN 48H -->RCTO-PCR-CREA-BUN-U-PF HEPATICO-FOSFORO-CALCIO-GASES EVALUACIÓN CON MEDICO EN 24H SEGUIMIENTO POR CUIDADOS PALIATIVOS CSV CADA 24H	NICOLÁS BRAVO ALVEZ

RECETAS:

Fecha	Prescripción	Profesional
18/09/2025 22:22	PARACETAMOL 500MG 2 COMP CADA 8H X SNG DICLOFENACO 300MG 2 COMP CADA 8H X SNG EN CASO DE DOLOR	NICOLÁS BRAVO ALVEZ

PARCHE DE BUPRENORFINA 1 PARCHE CADA 12H TRANSDERMICO
CEFTRIAXONA 2G CADA 24H EV (1/7)
OMEPRAZOL 20MG CADA 24H X SNG POR 7 DIAS
ONDANSETRON 4MG CADA 8H X SNG EN CASO DE NAUSEAS O VOMITOS

OBSERVACIONES:

Fecha	Indicación	Profesional
18/09/2025 17:12	SE INSTALA VVP Nª 22 ESI PRIMERA INTENCION	Felipe Lagos Fernandez
18/09/2025 17:21	Usuaria de 61 años, dependiente severa, con antecedentes de Mieloma múltiple en CP, alergias a meloxicam y prednisona. Traída en SAMU M1 por CEG, emesis de contenido fecaloideo, hipoalimentación. Ingresa en REG. Al CSV taquicárdica, resto hemodinamia estable. Al ex fisico Gls 10pts, quejumbrosa, piel pálida, tibia al tacto, masa palpable zona parietal izq del cráneo, restos emáticos en boca, yug planas, tórax simétrico normoexpansible, abd resistente a la palpación, no impresiona doloroso, movilidad muy limitada de extremidades por dolor. Se realiza sondeo intermitente con Nelaton #10, con técnica estéril. Se obtienen 400cc de orinas concentradas, de mal olor, leve sedimentosa. Se toma muestra para oc + urc.	Francisco Parada Riquelme
18/09/2025 19:10	Exs destaca PCR 392.5 / Leuc 22.6 / Segmentados 90.8/ Crea 2.4 / Uremia 206 / B Total 1.5 / Orina turbia e inflamatoria. CSV PA 78/50 Se da aviso a médico tratante indica de manera verbal: 500 cc SF 0.9 + Ceftriaxona 2gr en 100cc. Se administra tratamiento sim.	Francisco Parada Riquelme
18/09/2025 20:53	Se lleva paciente a TAC, a la espera de informe.	ANA OSSES FLORES
18/09/2025 21:41	SE RECIBE INFORME TC ABDOMEN Y PELVIS CON CONTRASTE Impresión: Gran masa expansiva de partes blandas con infiltración de planos musculares, sacro, isquion e ilion izquierdos de aspecto neoplásico según lo descrito. Plasmocitoma?, sarcoma? Múltiples lesiones líticas en esqueleto óseo visible de aspecto secundario. Adenopatías pelvianas, inespecíficas. Leve hidroureteronefrosis bilateral, probablemente por sobredistensión vesical. Masas pulmonares bilaterales, sugerentes de corresponder a compromiso metastásico secundario macroscópico a distancia.	Carolina Estefany Muñoz Leon
18/09/2025 22:13	SE CONVERSA CON FAMILIA PRONOSCOTICO Y SE DECIDE HODOM PARA ESTAR CERCA A FAMILIARES.	NICOLÁS BRAVO ALVEZ

GES : No **PERTINENCIA** : Si **DESTINO** : Domicilio

ADVERTENCIA
ESTE ES UN DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO Y SÓLO UNA PRIMERA ATENCIÓN. DEBE CONSULTAR A SU CENTRO DE SALUD O MÉDICO TRATANTE DENTRO DE LAS 12-24 HORAS SIGUIENTES. SI SUS SÍNTOMAS EMPEORAN, CONSULTE NUEVAMENTE A LA BREVEDAD. ES SU RESPONSABILIDAD SEGUIR ESTAS INDICACIONES.

LLAME A SALUD RESPONDE
600·360·7777
PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS, LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

NICOLÁS BRAVO ALVEZ
20.086.914-1